EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 71692
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2023-10-02 15:56:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: MARIA ELENA PINILLA PARRA			RUN	: 7.943.397-7
F.Nac	: 20-05-2023	Edad	: 0 AÑO, 4 MESES	Género	: Femenino
Dirección	:			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: SIN INFORMACION	Teléfono	: 0		
Fecha Ingreso	: 27-09-2023	Fecha Egreso	: 2023-10-02 15:56:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. R10.3-DOLOR LOCALIZADO EN OTRAS PARTES INFERIORES DEL ABDOMEN

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

IDX:
Insuficiencia respiratoria aguda:
-Neumonía bibasal
-Insuficiencia Cardiaca
ITU
Quiste cortical renal izquierdo
Hipertensión Arterial
Diabetes Mellitus tipo 2
Artrosis

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. J15.9-NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente ingresa bajo IDX de neumonía bilateral, historia de Mialgia, decaimiento, inapetencia. Antecedente de traumatismo reciente con impacto en hemicuerpo derecho.
Durante estancia, se toman exámenes de laboratorio donde se evidencia franca alteración de parámetros inflamatorios, además de TC alterada evidenciando neumonía bilateral.
Actualmente en mejores condiciones generales, persistiendo dolor en hemicuerpo derecho asociado a traumatismo previo.
En vista de condicion basal, y mejoria paraclínica, se decide egreso hospitalario.

PLAN DE MANEJO:

Hemodinámico: Estable, sin conflicto. Evitar sobrecarga de líquidos. Impresiona elevación de presión arterial durante estancia hospitalaria. Actualmente sin tratamiento. Paciente de mal control metabólico
Infeccioso: Paciente con disminución de cuenta blanca, impresiona leve disminución de parámetros inflamatorios. Actualmente en 6to dia con Ceftriaxona y Metronidazol(?). Resultado preliminar de HC reporta cocáceas grampositivas en cadena (Streptococo?) pendiente resultado final (impresiona que demorará más de lo esperado). Parámetros inflamatorios a la baja. Se sugiere completar 10 dias de terapia ATB dual.
Respiratorio: sin conflicto desde ingreso. Mantener terapia con BD.
Nefrometabólico: Mal controlada de larga data. Actualmente con insulina en esquema. Ultima funcion renal en rango.

INDICACIONES AL ALTA

1. Dieta liviana - Hiposódica - Diabética
2. Vigilar los signos de sobrecarga
3. Ceftriaxona 2 Gramos Ev día (6/10)
4. Metronidazol 500 Mg Cada 8 Horas vo (6/10)
5. Bromuro De Ipratropio 2 Puff Cada 6 Horas x AEC
6. Heparina 5000 U Cada 12 Horas Sc
7. Losartan 50mg c12h vo
8. Quetiapina 25mg vo noche
9. Paracetamol 1 Gramo vo c8h
10. Celecoxib 200mg vo c8h SOS
11. KNT R y MOTORA
12. Captopril 25 mg SL SOS PA >180/110
13. Insulina NPH 24 UDS AM 8 UDS PM
14. HGT precomida + IC segun esquema.
15. DERIVAR A HODOM

EXÁMENES Y RESULTADOS

TC TX: Destaca neumopatía bibasal

OBSERVACIONES:

Derivo HODOM

andres david velasquez guerra
MEDICO TRATANTE
27124399-5

JEFE SERVICIO